Chi cura chi non può ricambiare?

Santo Spirito in Sassia: dalla carità alla cura organizzata

Materiale ad uso personale dello studente

Un bambino appena nato dipende interamente dagli altri. Una persona malata può perdere, per un periodo o per sempre, la capacità di lavorare. Se l'aiuto fosse riservato a chi può restituire qualcosa, proprio alcune delle persone che ne hanno più bisogno resterebbero escluse. Santo Spirito in Sassia, a Roma, permette di affrontare la domanda attraverso un luogo: come si passa dal riconoscere un bisogno all'organizzare una cura che duri?

Un posto a tavola senza debiti

Nel Vangelo di Luca, Gesù è a pranzo, di sabato, in casa di uno dei capi dei farisei; dopo aver parlato agli invitati della scelta dei posti, si rivolge a chi lo ha invitato. [1]

> *«Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti.»*
>
> Vangelo secondo Luca 14,12–14, traduzione CEI 2008.

Un banchetto era anche uno scambio, si invita chi potrà invitare a sua volta: Gesù rovescia il criterio. Le quattro categorie che nomina, poveri, storpi, zoppi, ciechi, tornano poco dopo nella parabola del grande banchetto, quando il padrone manda il servo a cercarle per le piazze al posto degli invitati che hanno rifiutato (Lc 14,21). Il passo si chiude con la promessa di una ricompensa «alla risurrezione dei giusti»: il bene compiuto è affidato a Dio e al suo giudizio. Chi viene accolto, però, non deve saldare alcun debito: Gesù sottrae il rapporto con il bisognoso alla logica del favore da restituire. Il testo parla di una tavola, non di un ospedale; offre un criterio che può orientare anche altre forme di aiuto.

Chiamiamo **gratuità** questa disponibilità ad aiutare senza pretendere un vantaggio dal destinatario: la parola viene dal latino *gratuitus*, dalla stessa radice di *gratia*, e indica ciò che è concesso senza che chi riceve lo debba meritare. Nella fede cristiana la gratuità appartiene alla **carità** (dal latino *caritas*, «affetto, amore», da *carus*, «caro»): l'amore per Dio che prende forma nell'amore del prossimo, con il tempo, l'ascolto e il servizio, non solo con il denaro. Il Vangelo di Matteo lo dice con l'elenco delle «opere di misericordia»: sfamare, dissetare, accogliere lo straniero, vestire, visitare il malato e il carcerato, perché «tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

fatto a me» (Mt 25,35–40). La ragione religiosa della cura riguarda anzitutto chi la offre; non obbliga chi la riceve a ricambiare con denaro, obbedienza o adesione personale.

La gratuità non elimina i costi. Un pasto richiede alimenti, una stanza va mantenuta, chi assiste deve avere tempo e mezzi: se una comunità vuole accogliere anche chi non può pagare, deve trovare altre risorse. Qui nasce il problema dell'organizzazione: il gesto di oggi deve poter essere ripetuto domani, senza dipendere soltanto dall'entusiasmo di una persona.

L'ospedale comincia dall'ospitalità

La parola **ospedale** conserva una traccia di questa storia. Deriva dal latino *hospitale*, da *hospitalis*, «ospitale», e all'origine indicava un alloggio per i forestieri; *hospes*, da cui viene anche «ospite», era insieme chi accoglieva e chi era accolto. Nel Medioevo un *hospitale*, chiamato anche *xenodochium*, «casa dello straniero», era prima di tutto un luogo di ospitalità: vi si accoglievano anche i malati, ma perché la malattia era una delle forme del bisogno, non perché fosse un luogo di terapia. [2–3]

La cura ha una storia più ampia di una sola tradizione religiosa: l'antichità conobbe luoghi di terapia e infermerie militari, e nel mondo islamico, fin dall'VIII secolo, sorsero istituzioni per la cura delle malattie, con medici e scuole. Nell'Occidente cristiano l'ospitalità verso il bisognoso era già un dovere scritto: la Regola di san Benedetto, nel VI secolo, chiede che tutti gli ospiti siano accolti «come Cristo in persona» e che ci si preoccupi «soprattutto» dei poveri e dei pellegrini (Regola 53,1.15). Dall'XI secolo, con la ripresa dei commerci e dei pellegrinaggi verso Roma, Gerusalemme e Santiago, le strade si riempirono di viandanti che avevano bisogno di un tetto, di cibo e, se si ammalavano, di assistenza: per questo gli ospedali medievali sorgono lungo le vie e alle porte delle città. Pellegrinaggi, motivazione religiosa e mezzi disponibili si incontrano senza coincidere: la carità ha contribuito alla storia degli ospedali con un'azione concreta, senza essere da sola tutta la storia della medicina. [3]

Un'**istituzione** è un'organizzazione che rende durevole un compito: stabilisce chi se ne occupa, con quali risorse e sotto quale responsabilità. L'edificio ne è una parte, ma non basta: una sala vuota ripara dalla pioggia, ma per accogliere stabilmente persone fragili servono lavoro, continuità e decisioni. L'ospitalità diventa così una responsabilità condivisa.

Santo Spirito: un impegno prende forma

A Roma, fra il Vaticano e il Tevere, esisteva dall'VIII secolo l'ospizio dei pellegrini anglosassoni, la *schola Saxonum* fondata dal re Ina intorno al 727–729: da lì vengono il nome «Sassia» e, dal germanico *burg*, il nome «Borgo». Nel XII secolo quell'ospizio era in rovina.

Il papa che ne cambiò la storia fu **Innocenzo III**, al secolo Lotario dei Conti di Segni, eletto nel gennaio 1198 a meno di quarant'anni, che durante gli studi in Francia aveva conosciuto l'opera di **Guido di Montpellier**: un laico che, prima del 1190, aveva aperto nella sua città una casa-ospedale per i poveri, affidata allo Spirito Santo, con una comunità di fratelli e sorelle, laici e chierici. [4]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Nell'aprile 1198 Innocenzo III approvò la regola di quella comunità e scrisse che i suoi fratelli andavano chiamati «non tanto accoglitori dei bisognosi, quanto piuttosto servi». Nei primi anni di pontificato fece costruire un ospedale accanto alla chiesa di Santa Maria in Sassia; con una bolla del 10 dicembre 1201 lo affidò a Guido e ai suoi compagni e il 19 giugno 1204, con la bolla *Inter opera pietatis*, confermò l'ordine ospedaliero del Santo Spirito e la sua regola, i suoi compiti e il suo governo sulla casa romana, divenuta casa madre dell'ordine. Guido morì a Roma nel 1208. Alla fine del Duecento l'ordine contava un centinaio di case fra Italia, Francia e Germania, riconoscibili dal mantello con la croce a doppio braccio. [3–6]

La motivazione di Innocenzo III era quella delle opere di misericordia, che la bolla del 1204 elenca come compiti della casa. Una tradizione posteriore, dipinta negli affreschi del Quattrocento come storia delle origini, aggiunge un sogno del papa sui neonati gettati nel Tevere: i documenti del tempo non la attestano. [5]

La regola dell'ordine, confermata nel 1204, ci è arrivata nella forma del Duecento, in un codice miniato della metà del Trecento, il *Liber Regulae*, conservato all'Archivio di Stato di Roma. Vi si legge che i malati, giunti o portati alla casa, vanno accolti, per prima cosa confessati e comunicati, e poi messi a letto; che i fratelli devono cercare i poveri infermi per le strade e le piazze; che i poveri vanno vestiti e accolti anche se sani; che «gli orfani infanti proietti siano nutriti e le povere donne incinte siano accolte e accudite con carità». I «proietti» o **esposti**, i bambini abbandonati, diventavano «figli della casa» e imparavano un mestiere. La ruota di legno in cui lasciarli senza essere visti, ancora visibile sul fianco dell'edificio, è però del Seicento. [5, 7]

Una regola introduce un passaggio decisivo: l'accoglienza non resta affidata alla sensibilità di qualcuno, ma diventa un impegno della comunità, al quale si può chiedere conto. Una regola però dice che cosa si deve fare, non dimostra che cosa è accaduto: per saperlo servono altre fonti. Le pergamene dei lasciti, dal 1245, mostrano che privati cittadini donavano terre e denaro all'ospedale e ai suoi poveri: segno che l'opera era stimata, non prova che ogni ospite fosse ben curato. [5]

L'edificio di oggi conserva trasformazioni successive. Le **Corsie Sistine**, due lunghe sale affrescate, furono costruite fra il 1471 e il 1478 per volontà di **Sisto IV**, il papa francescano Francesco della Rovere, che rifece l'ospedale; gli affreschi raccontano le origini dell'ospedale, la ricostruzione e la vita dello stesso Sisto IV, con iscrizioni latine dell'umanista Bartolomeo Platina. Non sono dunque la sala di Innocenzo III: un'immagine dipinta quasi tre secoli dopo un evento testimonia come quell'evento veniva ricordato e quale messaggio il committente voleva trasmettere. [6–7]

Nella vicenda di Santo Spirito riconosciamo quindi tre elementi collegati, nessuno dei quali basta da solo: una motivazione cristiana, una comunità incaricata dell'assistenza, un luogo e una struttura destinati a durare. La fede spiega una ragione dell'impegno; l'organizzazione gli dà una forma concreta. Confonderli porta a due errori opposti: ridurre tutto ad amministrazione, o credere che una buona intenzione sia già una cura.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Bisogni diversi, uguale dignità

Consideriamo un **caso immaginario**, non una ricostruzione di Santo Spirito. Una piccola casa di accoglienza dispone già di pasti, posti letto e assistenza di base per tutti. Deve ora distribuire alcune ore aggiuntive di lavoro. Un ospite riesce a muoversi autonomamente ma ha bisogno di orientarsi nei servizi; un altro necessita di accompagnamento; un bambino richiede la presenza continuativa di un adulto. È sufficiente assegnare a ciascuno lo stesso intervento?

Un servizio identico potrebbe essere inutile per qualcuno e insufficiente per un altro. Il criterio da discutere è il bisogno concreto: quale aiuto manca, chi sa offrirlo e come garantire che continui? Non si scelgono vite da salvare né terapie: si riconosce che l'uguale valore delle persone può richiedere risposte differenti, motivate e verificabili.

La **dignità** (dal latino *dignitas*, da *dignus*, «degno») è il valore della persona, che non dipende dalla sua produttività né dalla capacità di restituire quanto riceve. La **produttività** indica invece quanto si riesce a produrre in una certa attività. Le due cose non coincidono: un adulto che perde il lavoro o si ammala non diventa, per questo, una persona di minor valore; un bambino non deve promettere che da grande sarà utile per meritare attenzione oggi. La regola di Santo Spirito lo diceva a modo suo: nutrire i proietti, neonati che non potevano dare nulla.

Ricevere assistenza non cancella la propria voce: chi organizza un servizio ascolta esigenze e preferenze e riconosce il bisogno senza ridurre una persona a quel bisogno. Le risorse restano limitate: riconoscere la dignità non significa promettere tutto a tutti, ma rendere ragione delle scelte senza misurare il valore umano con la ricchezza o il vantaggio che qualcuno potrebbe offrire. Nel caso immaginario, la proposta migliore sarà quella che spiega il rapporto fra ciascun bisogno e il servizio assegnato, anziché premiare chi potrebbe ricambiare.

La cura va anche verificata

La storia di un'istituzione religiosa non si valuta soltanto dalle sue intenzioni. La fondazione di un ospedale è un fatto importante, ma non dimostra da sola che ogni assistito ricevesse ciò di cui aveva bisogno: per giudicarlo occorrerebbe conoscere condizioni reali, risorse e funzionamento del servizio. Ammettere questo limite evita l'idealizzazione del passato e le accuse che le fonti non sostengono.

La Chiesa di oggi lo dice con chiarezza. Nell'enciclica *Deus caritas est* (2005) Benedetto XVI scrive che a chi serve i sofferenti «occorre innanzitutto la competenza professionale», che però «da sola non basta», perché gli esseri umani «hanno bisogno di umanità», dell'«attenzione del cuore»; e che, quando la carità è un'iniziativa della comunità, alla spontaneità del singolo devono unirsi «la programmazione, la previdenza, la collaborazione con altre istituzioni simili». [8]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

> *«L'amore è gratuito; non viene esercitato per raggiungere altri scopi. [...] Chi esercita la carità in nome della Chiesa non cercherà mai di imporre agli altri la fede della Chiesa.»*
>
> Benedetto XVI, *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 31c.

Il documento fissa un criterio dell'agire cristiano, utile anche per rileggere la storia; non descrive la pratica di ogni ospedale medievale. Ne deriva una conseguenza esigente: voler bene a una persona richiede anche imparare a servirla bene, con turni, preparazione e ascolto. Il lavoro retribuito non annulla la gratuità verso il beneficiario; la generosità, da sola, non sostituisce la competenza.

Per lo studio

1. In Luca 14,12–14 quale criterio dell'invito cambia? Distingui la ricompensa promessa da Dio dal contraccambio richiesto all'ospite.

2. Perché la parola «ospedale» non va applicata al Medioevo immaginando una struttura identica a quella odierna? Distingui le origini di Santo Spirito (1198–1204) dalle Corsie Sistine.

3. Nel caso della casa di accoglienza, assegna due servizi a due bisogni differenti e motiva le scelte. Perché la possibilità di ricambiare non misura la dignità degli ospiti?

4. Il *Liber Regulae* prescrive di cercare i poveri per le strade e di nutrire gli esposti: che cosa dimostra e che cosa resta da verificare? Perché gratuità, risorse e competenza devono stare insieme?

Chi cura chi non può ricambiare? Nel caso studiato, una comunità che traduce la carità cristiana in un compito stabile: un papa che fonda, un ordine che serve, una regola che dice chi accogliere, con risultati da verificare. La persona viene prima del vantaggio che può offrire; per questo la cura ha bisogno di mezzi, competenze e continuità, e non diventa mai un debito di chi la riceve.

Fonti e riferimenti

— [1] Bibbia, traduzione CEI 2008: Luca 14,1–24 e Matteo 25,31–46, bibbiaedu.it.

— [2] Treccani, Vocabolario: «Ospedale», «Ospite», «Carità», «Gratuito», «Dignità» (etimologie).

— [3] B. D'Agosta e I. Moretti, «Ospedale», in *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, Treccani, 1997; San Benedetto, *Regola*, cap. 53, traduzione dei Benedettini di Noci, Edizioni La Scala.

— [4] Francesco, lettera apostolica *Fide incensus*, 18 maggio 2024, vatican.va (Guido di Montpellier; bolle del 1198, 1201 e 1204).

— [5] F. Micciarelli, «L'ospedale di Santo Spirito in Saxia di Roma nel Duecento», *Medicina nei secoli* 25/2 (2013), pp. 565–580 (*Liber Regulae*, pergamene).

— [6] W. Maleczek, «Innocenzo III», e G. Lombardi, «Sisto IV», in *Enciclopedia dei Papi*, Treccani, 2000.

— [7] ASL Roma 1, Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia e comunicato sul restauro delle Corsie Sistine (affreschi, ruota seicentesca).

— [8] Benedetto XVI, *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 31 a–c; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1822 e 2447.

— Riferimenti consultati l'8 ottobre 2026; il caso della casa di accoglienza è immaginario.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati